Ministerio de Educación

Formulario Único de Evaluación Integral
Acta de cierre

Ley 20.201 – Decreto 170/2009
Evaluación Diagnóstica Integral de Necesidades Educativas Especiales

ENTREVISTA A LA FAMILIA / ANAMNESIS

Síntesis de los antecedentes de salud, escolares y sociales del estudiante

Esta pauta –de uso optativo- ha sido diseñada para facilitar a los profesionales que realizan los procesos de evaluación de NEE, en el marco del Decreto 170, la recogida de antecedentes de anamnesis relevantes del estudiante. Puede ser completada por uno o más profesionales en el proceso de detección y evaluación de las NEE que presenta el alumno (a) y de los apoyos que requiere para aprender y participar en el contexto escolar.

1. DENTIFICACIÓN DEL ESTUDIANTE

Nombre	Dainer Henrique Duque Velandia				Sexo	F	M X
Fecha Nacimiento	11.09.2018	Edad actual	6 años	meses	País natal:	Ecuador	
Domicilio actual:	San Esteban Calle Arauco #291			Teléfono	985711019		
Lengua materna	Español	Grado dominio	comprende ☑ habla ☐ lee ☐ escribe ☐				
Lengua de uso	Español	Grado dominio	comprende ☑ habla ☑ lee ☐ escribe ☐				
Escolaridad actual:	1° Básico	Establecimiento	Liceo Mixto Los Andes Básico N°1				

2. IDENTIFICACIÓN DEL O LOS INFORMANTES

1. Fecha de la entrevista: 03.04.2025	2. Fecha de la entrevista:
Nombre: Norelkis Velandia	Nombre:
Relación con el/la estudiante: madre	Relación con el/la estudiante:
En presencia de (miembro de la familia, intérprete, otro/a)	En presencia de (miembro de la familia, intérprete, otro/a):
3. Fecha de la entrevista:	4. Fecha de la entrevista:
Nombre:	Nombre:
Relación con el/la estudiante:	Relación con el/la estudiante:
En presencia de (miembro de la familia, intérprete, otro/a)	En presencia de (miembro de la familia, intérprete, otro/a):

3. IDENTIFICACIÓN DEL O LOS ENTREVISTADORES

1. Fecha de la entrevista: 03.04.2025	2. Fecha de la entrevista:
Nombre: Yesenia Jara Valero	Nombre:
Rol/cargo: Ed. diferencial	Rol/cargo:
3. Fecha de la entrevista:	3. Fecha de la entrevista:
Nombre:	Nombre:
Rol/cargo:	Rol/cargo:

4. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA O SITUACIÓN QUE MOTIVA LA ENTREVISTA

Dificultad del lenguaje.

5. ANTECEDENTES RELATIVOS AL DESARROLLO Y A LA SALUD DEL/LA ESTUDIANTE

¿El o la estudiante tiene algún diagnóstico previo? ☐ No ☑ SI (especificar)	
Pediatría:	Psicología:
Kinesiología:	Psiquiatría:

LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO SON CONFIDENCIALES, SU DIVULGACIÓN O USO INDEBIDO ES PENADA POR LA LEY

Ley 20.201 – Decreto 170/2009
Evaluación Diagnóstica Integral de Necesidades Educativas Especiales

ENTREVISTA A LA FAMILIA / ANAMNESIS

Síntesis de los antecedentes de salud, escolares y sociales del estudiante

5.1. Primer año de vida

Tipo de parto: ☐ normal ☐ inducido ☐ fórceps ☑ cesárea (señalar motivo)

Tuvo asistencia médica durante el parto? ☑ SI ☐ NO | Peso: 3. Kg. | Talla: 48 cms.

Señale antecedentes relevantes del Embarazo y Parto:

Embarazo con Nauseas y malos extremos.

Señale si durante los doce primeros meses de vida el niño o niña presentó:

Desnutrición	~~Si~~	No	Traumatismos	Sí	No	Encefalitis	Sí	No
Obesidad	Sí	No	Intoxicación	Sí	No	Meningitis	Sí	No
Fiebre alta	Sí	No	Enfermedad respiratoria	Sí	No	Otra(s)		
Convulsiones	Si	No	Asma	Sí	No			
Hospitalizaciones	Sí	No	Especifique motivos y duración:					

Se realizaron controles periódicos de salud	Sí	No	Vacunas	Si	No

Observaciones:

Al llegar a Chile a los 5 meses presentó un resfriado muy fuerte, comia y vomitaba lo que provoco desnutrición

5.2. Desarrollo Sensorio Motriz

Edad en que el niño (a)

Fija la cabeza: 4 M.	Se sienta sólo/a: 10 M.	Camina sin apoyo: 18 M.
Primeras palabras: 10 M	Primeras frases: 12 M.	Se viste solo/a: 3 AÑOS.
Controla esfinter vesical Diurno: ✓ Nocturno: ✓ 4 años		Controla esfinter anal Diurno: ✓ Nocturno: ✓ 4 Años

Observaciones:

presento un desfaz del desarrollo, es bajo, no crecio como debria.

En su actividad motora general se aprecia:
☐ normal ☐ activo ☑ hiperactivo ☐ hipoactivo

Su tono muscular general se aprecia:
☑ normal ☐ hipertónico ☐ hipotónico

En relación con su motricidad gruesa se aprecia:

Estabilidad al caminar	~~Si~~	No	Caidas frecuentes	Si	~~No~~	Dominancia lateral	~~Si~~	No

En relación con su motricidad fina el niño (a) logra:

Garra	~~Si~~	No	Prensión	~~Si~~	No	Pinza	~~Si~~	No
Ensarta	~~Si~~	No	Dibuja	~~Si~~	No	Escribe	~~Si~~	No

En relación con algunos signos cognitivos el niño (a)

Reacciona a voces o caras familiares	~~Si~~	No	Manipula y Explora objetos	~~Si~~	No
Demanda objetos y compañia	~~Si~~	No	Comprende prohibiciones	~~Si~~	No
Sonríe, balbucea, grita, llora, indica o señala	~~Si~~	No	Posee evidente descoordinación ojo-mano	Si	~~No~~

Observaciones:

Sin antecedentes relevantes

LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO SON CONFIDENCIALES, SU DIVULGACIÓN O USO INDEBIDO ES PENADA POR

Ley 20.201 – Decreto 170/2009
Evaluación Diagnóstica Integral de Necesidades Educativas Especiales

ENTREVISTA A LA FAMILIA / ANAMNESIS

Síntesis de los antecedentes de salud, escolares y sociales del estudiante

Observaciones:
Sin antecedentes

5.3. Visión - Audición:					
Se interesa por los estímulos visuales (colores, formas, movimientos, etc.)	Sí	No	Se interesa por los estímulos auditivos (ruidos, voces, música, etc.)	Sí	No
En ocasiones tiene los ojos irritados o llorosos	Sí	No	Reacciona o reconoce voces o sonidos familiares	Sí	No
Presenta dolores frecuentes de cabeza	Sí	No	Gira la cabeza cuando se le llama o ante un ruido fuerte	Sí	No
Se acerca o aleja demasiado los objetos a la vista (frunce el ceño)	Sí	No	Acerca los oídos a la TV, radio o fuente de sonido.	Sí	No
Sigue con la vista el desplazamiento de los objetos o personas	Sí	No	En ocasiones se tapa o golpea los oídos	Sí	No
Presenta movimientos oculares "anormales"	Sí	No	Presenta frecuentes dolores de oídos	Sí	No
Manifiesta conductas "erróneas" (tropiezos, choques)	Sí	No	La pronunciación oral es adecuada	Sí	No
Presenta diagnóstico médico de miopía, estrabismo, astigmatismo, u otro.	Sí	No	Presenta diagnóstico médico de otitis crónica, hipoacusia u otra.	Sí	No

Observaciones:
Sin Antecedentes.

5.4. Desarrollo del Lenguaje

El niño (a) se comunica preferentemente en forma

☐ oral ☐ gestual ☑ mixto ☐ otro (especifique):

Características del lenguaje expresivo					
Balbucea (oral o señas)/emite sonidos	Sí	No	Emite/produce frases	Sí	No
Vocaliza/realiza gestos o señas aisladas	Sí	No	Relata experiencias	Sí	No
Emite palabras/produce señas	Sí	No	La emisión/pronunciación/producción es clara	Sí	No
Características del lenguaje comprensivo					
Identifica objetos	Sí	No	Sigue instrucciones simples	Sí	No
Identifica personas	Sí	No	Sigue instrucciones complejas	Sí	No
Comprende conceptos abstractos	Sí	No	Sigue instrucciones grupales	Sí	No
Responde en forma coherente preguntas de la vida diaria	Sí	No	Comprende relatos, noticias, cuentos cortos	Sí	No

Manifestó pérdida del lenguaje oral (especifique edad y motivos):

Observaciones:
Logro todos los hitos del desarrollo del lenguaje solo que con un desfase de tres meses, según lo que le indicaba la pediatra.

5.5. Desarrollo Social					
Se relaciona espontáneamente con las personas de su entorno natural.	Sí	No	Se relaciona en forma colaborativa	Sí	No
Explica razones de sus comportamientos y actitudes	Sí	No	Respeta normas sociales	Sí	No
Participa en actividades grupales	Sí	No	Respeta normas escolares	Sí	No

3

LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO SON CONFIDENCIALES, SU DIVULGACIÓN O USO INDEBIDO ES PENADA POR LA LEY

Ley 20.201 – Decreto 170/2009
Evaluación Diagnóstica Integral de Necesidades Educativas Especiales

ENTREVISTA A LA FAMILIA / ANAMNESIS

Síntesis de los antecedentes de salud, escolares y sociales del estudiante

5.6. Estado Actual de Salud del/la Estudiante

Vacunas al dia	~~Si~~	No	Trastorno motor	Sí	~~No~~
Epilepsia	Sí	~~No~~	Problema bronco-respiratorio	Sí	~~No~~
Problemas cardiacos	Sí	~~No~~	Enfermedad infecto-contagiosa	Sí	~~No~~
Paraplejia	Sí	~~No~~	Trastorno emocional	Sí	~~No~~
Pérdida auditiva	Sí	~~No~~	Trastorno conductual	Sí	~~No~~
Pérdida visual	Sí	~~No~~	Otro (especifique):		

El o los problemas de salud reciben control/tratamiento (especifique):
Sin antecedentes.

Alimentación: ☐ normal ☑ "malo/a" para comer ☐ "bueno/a" para comer ☐ Otro (especifique)

Peso (apreciación del informante): ☑ normal ☐ bajo peso ☐ obesidad

Sueño: ☑ normal ☐ tranquilo ☐ inquieto Horas que duerme: 10 hrs.

☐ insomnio ☐ pesadillas ☐ terrores nocturnos
☐ sonambulismo ☑ despierta de buen humor

Duerme: ☐ solo ☑ acompañado
(Especifique): con madre o hermanos.

Humor/comportamiento ***(señale el comportamiento habitual)***

☑ alegre ☑ juguetón/bromista ☐ risueño(a) ☐ triste ☐ serio ☐ rebelde ☐ apático ☐ violento(a)
Otro:

Observaciones:
Su peso es normal para su tamaño, es pequeño para tener 6 años. Bromea mucho - tenía apnea, Está con terapia con foro audiología.

6. ANTECEDENTES FAMILIARES

Personas que viven con el niño o niña y/o que son que son responsables de su cuidado.

Nombre	Parentesco	Edad	Escolaridad	Ocupación actual
1. Norelkis Velandia	Madre	33	4°	Repostera.
2. Gerson Duque	Papa	36	4°	Chofer
3. Daniela Duque	hermana	12	7° B.	Estudiante.
4. Daniel Duque	hermano	13	8° B.	Estudiante
5.				
6.				
7.				
8.				

Antecedentes de Salud de la Familia

(Señale aquellos antecedentes que son relevantes en función de la entrega de apoyos que requiere el o la estudiante):

No existen antecedentes.

Observaciones:

Sin observaciones

Ley 20.201 – Decreto 170/2009
Evaluación Diagnóstica Integral de Necesidades Educativas Especiales

ENTREVISTA A LA FAMILIA / ANAMNESIS

Síntesis de los antecedentes de salud, escolares y sociales del estudiante

Antecedentes de Salud de la Familia
*(Señale aquellos **antecedentes que son relevantes en función de la entrega de apoyos que requiere** el o la estudiante):* Sin Antecedentes
Observaciones: Sin antecedentes.

7. ANTECEDENTES ESCOLARES Y APOYO DE LA FAMILIA

Trayectoria escolar

Edad de ingreso al sistema escolar	4	Asistió a jardín infantil	Sí	☑ No
N° de colegios en que ha estudiado	1	Modalidad de enseñanza Regular ☐ Especial ☐ Técnica ☐:		

Motivo de los cambios: no aplica.

Ha repetido curso/s	Sí	☑ No	Curso(s)	Motivo:

Situación actual

Nivel/curso actual	1°		**Dificultad de aprendizaje**	Sí	☑ No	**Dificultad para participar**	Sí	☑ No	**Conducta disruptiva**	Sí	☑ No
Asiste regularmente	☑ Sí	No	**Asiste con agrado**	☑ Sí	No	**Apoyo familiar en tareas**	☑ Sí	No	**Amigos (as)**	☑ Sí	No

Actitud de la familia

¿Cómo evalúa la familia el desempeño escolar del estudiante?
☑ satisfactorio ☐ insatisfactorio (motivos) .....

¿Cuál es la respuesta de la familia frente a las dificultades escolares del estudiante?
☑ apoyo ☐ castigo ☐ indiferencia ☐ compasión ☐ tensión ☐ otra .....

¿Cuál es la respuesta de la familia frente a los éxitos escolares del estudiante?
☑ apoyo ☐ indiferencia ☐ otra .....
Especifique el tipo de refuerzos o premios:
☑ expresiones afectivas ☑ alimentos preferidos ☑ ver TV ☐ juguetes ☐ tiempo libre ☐ otro(s).....

¿Quiénes apoyan el proceso de aprendizaje y desarrollo del estudiante?
☑ madre ☐ padre ☐ hermanos/as ☐ Otros familiares ☐ Otros profesionales .....

¿Qué expectativas muestra la familia frente al futuro escolar del estudiante?
☑ alta (incluye al grupo familiar) ☐ mediana (incluye sólo madre/padre) ☐ baja (no incluye a ningún miembro)

¿Ofrece la familia un ambiente físico y emocional adecuado para el aprendizaje?
☑ Ambos ☐ Sólo físico (espacios, materiales, ventilación, luminosidad) ☐ Sólo emocional (tranquilo, relajado, comprensivo)

5

LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO SON CONFIDENCIALES, SU DIVULGACIÓN O USO INDEBIDO ES PENADA POR LA LEY